

Миома матки, железистая гиперплазия эндометрия и нейроэндокринные нарушения — факторы риска развития рака эндометрия

Аликулова У.А.

Жамбылский областной онкодиспансер

Актуальность

Среди злокачественных опухолей органов репродуктивной системы у женщин наиболее высока заболеваемость раком молочной железы, шейки матки, тела матки и яичников. Рак молочной железы в последние годы в ряде развитых стран вышел на первое место среди злокачественных опухолей у женщин. В течении последнего десятилетия отмечается отчетливая тенденция снижения заболеваемости инвазивным раком шейки матки (РШМ), что объясняется широким применением профилактических осмотров и цитологического скрининга с последующим лечением дисплазии преинвазивного рака. Это является надежной профилактикой развития инвазивного рака шейки матки. В 1970 г. в СССР впервые зарегистрировано 32782 больных РШМ (25,1 на 100 000 женщин), в 1980 г. - 29539 (20,8 на 100 000), а в 2009 году по РК - 8,5%000.

Цель работы

— определение частоты заболеваемости раком эндометрия среди больных миомой матки, гиперплазией эндометрия и нейроэндокринными нарушениями.

Материал и методы

Обработаны данные всехзарегистрированных больных. Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезней больных с диагнозом рак эндометрия

Результаты

Одновременно со снижением заболеваемости РШМ нарастает заболеваемость раком тела матки (РТМ). В 1970г. в СССР было впервые зарегистрировано 8419 больных РТМ (6,4 на 100 000 женщин), а в 1980г. - 13962 (9,8 на 100 000). К началу 90-х годов в СССР рак тела матки «перегонит» рак шейки матки. (В. М. Мерабишвили, 1986). В 1990-1995гг. странах СНГ заболеваемость РТМ колеблется от 4,0-5,2%000 (в республиках Средней Азии) до 8-14,7%000 (в России, Молдаве, Казахстане, Беларуси). Показатели заболеваемости РТМ были высокими в 2000 году - 12,2%000, последующие годы они остаются почти на одном уровне. В 2009 году по РК было зарегистрировано 811случай РТМ, заболеваемость составила - 5,6%000, в течении последних 5 лет она была стабильной.

В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями по РК РТМ в 2009 году находится на 10 ранговом месте, среди женщин - на 6-ом месте, а по гениталия - на 2 месте, составляя - 5,6 % 000. По Жамбылской области зарегистрировано 25 случаев РТМ, среди злокачественных новообразований на 12 ранговом месте, по гениталия - на 3 месте, заболеваемость составила - 3,2 %000.

Общая тенденция заболеваемости раком органов репродуктивной системы у женщин - это увеличение числа гормонозависимых опухолей. В основе этой тенденции нахо-

Жатыр миомасы, Бездік гиперплазия ээдометрич және нейроэндокринді бұзылу ө эндометрич регіне қаупті факторлар

Аликулова У.А.

Өткен уақыттағы 2007-2009 жылдардағы диагнозы эндометрия регі болған 46 аурулар тарихына талдау жасалды. Жамбыл облыстық онкология диспансерінде емделген 34 пен 81 жас аралығында. Олардың 31 пациенттері эндометрия рагі жатыр миомасына-сымен үлескен, бездік гиперплазия эндометрия және нейроэндокринді бұзылу.

дится существенное увеличение в популяции эндокринно-обменных нарушений, присущих болезням цивилизации, как ановуляция, гиперэстрогения, бесплодие, ожирение, сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Существенная роль обменно-эндокринных нарушений в организме обуславливает развитие гиперпластических процессов, а также возникновение на этом фоне неопластической трансформации (этиологию и патогенез гормонозависимых опухолей органов репродуктивной системы можно представить в виде треугольника, одна сторона которого эндокринно-обменные нарушения, вторая-генетические факторы, а третья-канцерогенные воздействия, реализующие на фоне первых двух).

К группе повышенного риска наряду с женщинами страдающими нейро-эндокринными нарушениями, рецидивирующими гиперпластическими процессами эндометрия, отнесены также больные миомой матки.

Научными работами последних лет доказана возможность развития рака эндометрия, так и миомы матки в соответствии с двумя патогенетическими вариантами. У 60-70% больных раком эндометрия имеют место предшествующие или сопутствующие нейроэндокринные нарушения, являющиеся следствием ановуляции и гипоталамо-гипофизарной дисфункции. У 30-40 % больных таких нарушений выявить не удается. У 10-60% РТМ сочетается с фибромиомой матки, ЖГЭ и НЭН.

С наступлением менопаузы миома матки часто подвергается обратному развитию. Это обуславливает снижение онкологической настороженности и пассивную врачебную тактику по отношению к женщинам с мало- и бессимптомными миомами в пре-, пери-, постменопаузальных возрастных периодов.

Также РЭ, как правило, развивается в небольших по размерам миоматозных матках со стертой симптоматикой, неправильной тактикой лечений ЖГЭ.

Все изложенное позволяет заключить, что нарушение в репродуктивном и энергетическом гомеостазах могут играть ключевую роль в создании условий для развития гиперпластических состояний и рака эндометрия и служит

Таблица 1. Распределение больных по возрастным группам

Диагноз	Возраст обследованных больных (лет)											
	30-40		41-50		51-60		61-70		71 и более		Всего	
РЭ	2	4,3%	8	17,3%	15	32,6%	12	26%	9	19,5%	46	100%
РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН.	1	3,2%	3	9,6%	12	38,7%	9	29%	6	19,3%	31	100%

Таблица 2. Распределение больных раком эндометрия в зависимости от морфологической структуры опухоли.

Морфологическая структура опухоли	Всего больных		Рак эндометрия		Рак эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН.	
	Абс. число	%	Абс. число	%	Абс. число	%
Высокодифференцированная аденокарцинома	25	55,5	8	66,6	17	51,5
Умереннодифференцированная аденокарцинома	9	20,0	2	16,6	7	21,2
Низкодифференцированная аденокарцинома и недифференцированная аденокарцинома	8	17,7	2	16,6	6	18,1
Выраженная дисплазия по типу <i>ca in situ</i> , атипическая гиперплазия с малигнизацией	3	6,6	0	0	3	9,0

Таблица 3. Распределение больных в зависимости от стадии заболевания

Стадия рака эндометрия	Рак эндометрия		РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН.	
	Абс. число	%	Абс. число	%
I	27	58,6	19	59,3
II	9	19,5	7	21,8
III	7	15,2	3	9,3
IV	0	0	0	0
Ca in situ	3	6,5	3	9,3

факторами риска развития данного вида новообразования. Поэтому активное выявление предраковых процессов путем обследования групп риска больных с нейроэндокринными нарушениями и миомой матки сможет предотвратить развитие рака эндометрия у данного контингента.

Проведен ретроспективный анализ 46 историй болезней больных с диагнозом рак эндометрия, обследованных и получивших лечение в отделении онкогинекологии Жамбылского областного онкодиспансера за период 2007-2009 г. Возраст больных колеблется от 34 до 81 лет.

В результате исследования установлено, что среди больных РЭ в 31 (67,3%) случаев сочетался с миомой матки, ЖГЭ и НЭН, т. е. у каждого второго больного. Наибольший процент рака сочетания с миомой матки, ЖГЭ и НЭН (12 случаев-38,7%) пришелся на возрастную группу от 51-60 лет. У больных раком эндометрия основная возрастная группа соответствовала также 51-60 лет (15 случаев-32,6%), 61-70 лет (12 случаев-26,0%).

Исследования показали, что у женщин в возрасте 51-70 лет рак эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ, НЭН и с раком эндометрия имеет тенденцию к росту в возрасте от 51 лет и выше (таблица №1).

При сравнительной характеристике морфологической структуры у исследованных больных были выявлены следующие особенности опухолей. В группе больных РЭ в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН высокодифференцированная аденокарцинома встречалась у 17 (51,5%) пациенток; умереннодифференцированная у 7 (21,2%), а у низко- и недифференцированная аденокарцинома отмечалась у 6 (18,1%) женщин.

В группе больных раком эндометрия у 25(55,5%) отмечена высокодифференцированная аденокарцинома, у 9(20,0%) умереннодифференцированная, а низко- и недифференцированная аденокарцинома у 8(17,7%) больных.

Частота высокодифференцированной аденокарци-

номы в группе больных раком эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН оказалась выше на 51,5% (таблица №2).

У больных раком эндометрия в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН с 0 стадией заболевания встречалась у 3 (6,5%) больных, I стадия у 19 (59,3%) больных, II стадия у 7 (21,8%) больных, III стадия у 3 (9,3%) больных, IV стадия - 0 (0%).

Из 46 больных раком эндометрия 0 стадия наблюдались в 3 (6,5%)

случаях, I стадия в 27 (58,6%) случаях, II стадия в 9 (19,5%), III стадия в 7 (15,2%), IV стадия в 0 (таблица 3).

Таким образом в нашем исследовании высокая выявляемость с ранними стадиями рака эндометрия 0 стадии 3(6,5%), I-стадии 27(58,6%) и в сочетании с миомой матки, ЖГЭ и НЭН 0-стадии 3(9,3%), I-стадии 19(59,3%), что связано с наличием ранней клинической симптоматики.

Всем больным проводилось специальное лечение с учетом стадии заболевания и морфологической структуры опухоли: хирургическое в объеме экстирпация матки с придатками, расширенная экстирпация матки, комбинированное-хирургическое+лучевое+гормонотерапия, сочетано лучевая+гормонотерапия при противопоказании оперативного лечения.

Таким образом, полученные нами данные еще раз подтверждают, что многие факторы риска развития рака эндометрия, ЖГЭ идентичны и обусловлены единым патогенезом. Поэтому больные миомой матки, особенно в сочетании с нейроэндокринными заболеваниями, т. е. заболеваниями цивилизации, должны относиться к группе риска по возникновению рака эндометрия.

Выводы

Улучшение диагностики и снижение заболеваемости раком эндометрия возможна лишь при отборе групп риска и патогенетическом лечении выявленных фоновых и предраковых процессах тела матки.

Необходимо, чтобы больные миомой матки, особенно старше 40 лет проходили ежегодное обследование с целью активного раннего выявления предраковых состояний и рака эндометрия, не ограничиваясь динамическим диспансерным наблюдением.

Целесообразно активное динамическое наблюдение за женщинами с различными нейроэндокринными нарушениями, такими как ожирение, артериальная гипертензия, сахарный диабет, входящими в группу риска по развитию неопластических процессов женской половой сферы.

Список литературы

1. Бохан Я. В. Руководство по онкогинекологии.-М., 1989.-464с.
2. Мезинова Н. Н., Патрушева А. С. Диагностика предрака и рака эндометрия у больных миомой матки в пре- и постменопаузе // Акушерство и гинекология.-1985.-№11. -С.30-32.
3. Вихляева Е. М. Руководство по эндокринной гинекологии.-М., 2000.-С. 424-487.
4. Арзыкулов Ж.А., Сейтказина Г.Д., Игисинов С.И. и др. Показатели онкологической службы РК за 2006- 2009 годы (статистические материалы).-Алматы, 2006-2009 годы.